



החייאת ילדים ותינוקות CPR

חיל הרפואה. בשבילך.



נכתב ע"י: לידור זילברברג, נצ"ס אורגני

הגדרת גילאים



הבדלים אנטומיים ופיסיולוגיים



גופם של תינוקות וילדים בנוי ופועל בצורה שונה מזה של מבוגרים:

ראש גדול ביחס לגוף

01

דופק ונשימה מהירים

02

לשון גדולה

03

נפח דם קטן

04

לרוב, הגורמים להחייאה יהיו בעיה נשימתית, מוות בעריסה, מומי לב מולדים

בדיקת הכרה



נחלק מההתרשמות המהירה מסימני חיים נבצע בתחילה בדיקת הכרה:

▪ **Voice - חילולית:** צרור מפתחות/ רעש מתון אחר

▪ **Pain - פיזית:** צביטות בכף הרגל/ שפשוף בגב



קריאה לעזרה



יש להזעיק עזרה נוספת ברגע שמזוהה דום הלב!



בדיקת דופק ונשימה



בדיקת נשימה:

הנחת יד על ביהח"ז עד כ- 10 שניות (יש/אין)

בדיקת דופק:

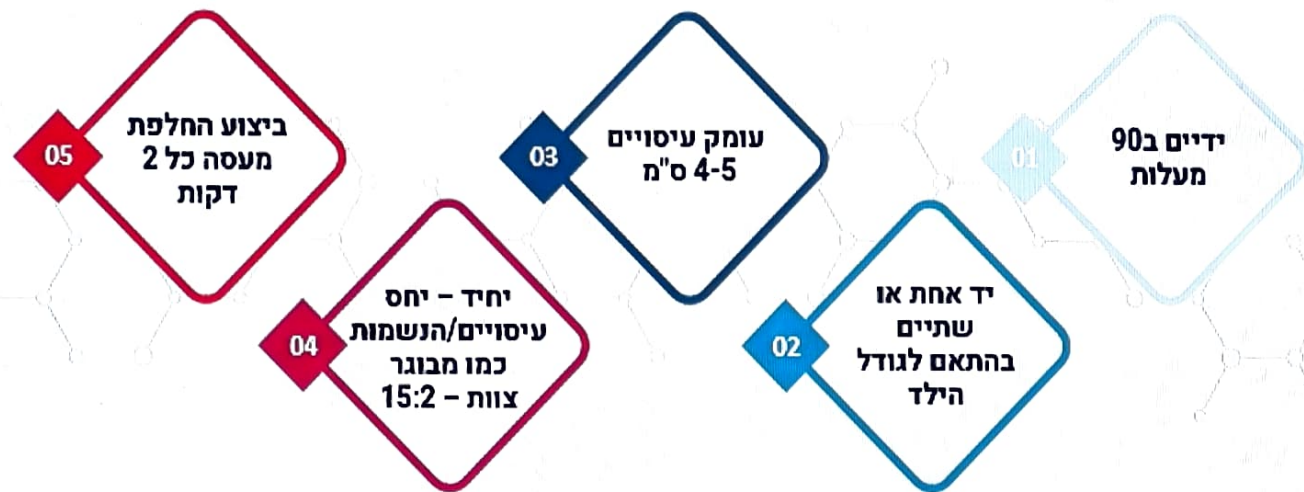
- התרשמות מקיום דופק בעורק הברכיאלי (זרוע) עד כ- 10 שניות (יש/אין)
- בהיעדר דופק = התחלת עיסויים

בנוכחות דופק =

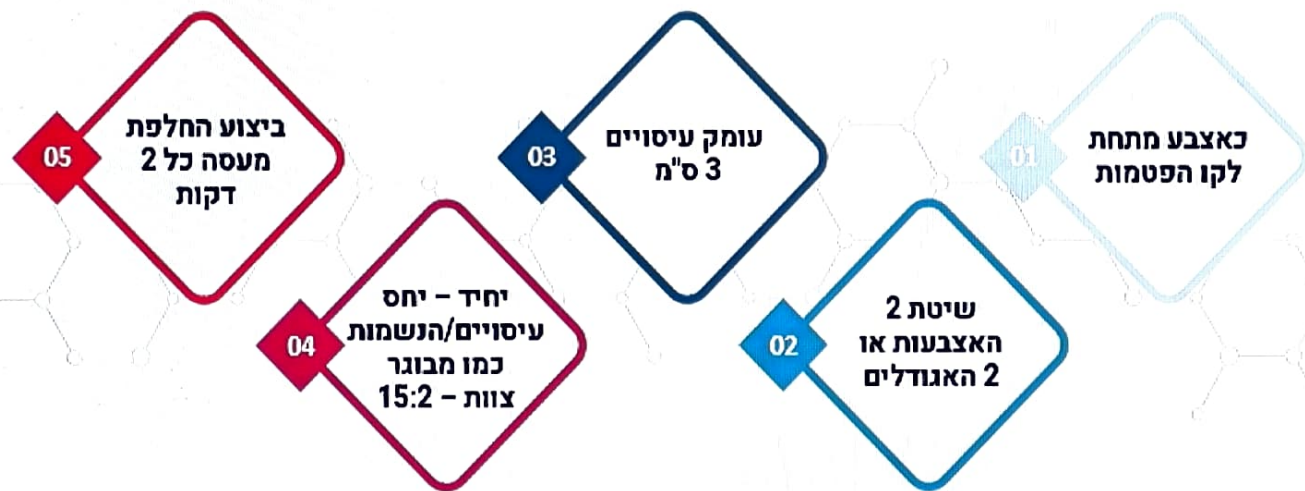
פתיחת נ"א והנשמה בכל 3 שניות בתינוקות, ובילדים כל 4 שניות
וודא דופק בכל 2 דקות



דגשים לעיסויים - ילדים



דגשים לעיסויים - תינוקות



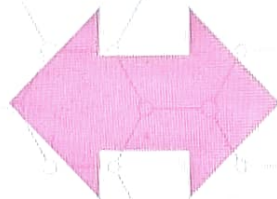
פתיחת נ"א והנשמה - ילדים



01



סילוק הפרשות
ופתיחת נ"א בשיטת
מצח סנטר Head Tilt



02



ביצוע 2 הנשמות
באמצעות אמבו:
לפחות שנייה, ועד
לעליית בית חזה

במידה ואין אמבו – אין לבצע הנשמה מפה לפה!

פתיחת נ"א והנשמה - תינוקות



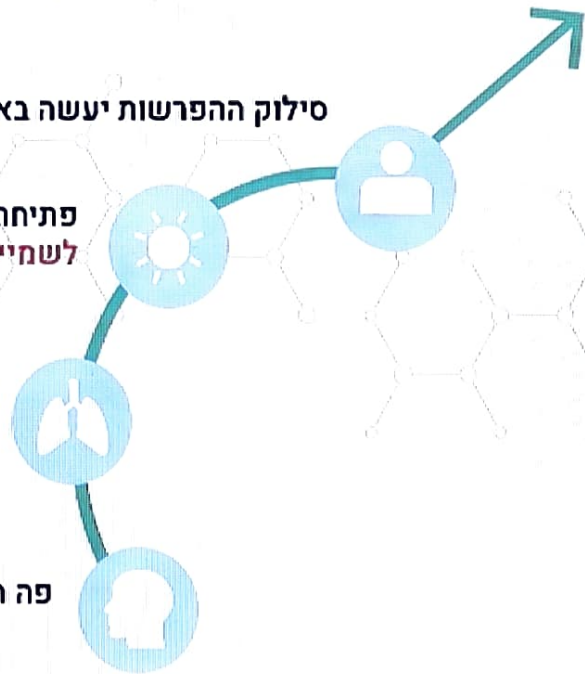
רק בתינוקות נבצע הנשמה מפה לפה!

סילוק ההפרשות יעשה באמצעות הפיכת התינוק כאשר **ראשו** נמוך **מגופו** בין העיסויים להנשמות

פתיחת נתיב האוויר תתבצע על ידי תנוחת "מבט לשמיים"

ביצוע 2 הנשמות מפה לפה, עד לעליית בית חזה נפח ההנשמה יהיה כ"נפח לחיים"

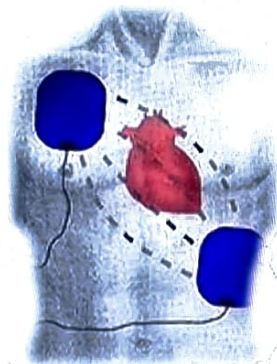
פה המטפל צריך לכסות אפו ופיו של התינוק במקביל



חיבור הדפירילטור



יתבצע בהקדם האפשרי



בתינוקות - הדבקת המדבקות כאשר אחת באמצע בית החזה

והשנייה בגב- בין השכמות

בילדים - חיבור מדבקות דפירילטור יבוצעו כמו אצל המטופל

המבוגר

הפסקת החיאה



01

בעת הגעת צוות ALS

02

כשהמטופל מתנגד
להחיאה - המטופל זז

לא נתחיל החיאה במקרה של אובדן צלם אנוש.

במקרה זה יש ליצור קשר עם גורם אחראי לקבלת אישור לאי ביצוע החיאה